

НЕЙРОСИФИЛИС

**Современные представления
о диагностике и лечении**

Руководство для врачей

Под редакцией А. В. Самцова

Санкт-Петербург
СпецЛит
2006

УДК 616.5 616.8 616.9
Н38

Авторы:

А. В. Самцов — доктор мед. наук, профессор;
Г. Е. Труфанов — доктор мед. наук, профессор;
А. М. Иванов — доктор мед. наук; *Н. А. Тотолян* — доктор мед. наук;
М. Н. Никоненко — канд. мед. наук; *О. М. Одинак* — канд. мед. наук;
И. Н. Теличко — канд. мед. наук; *А. А. Готовзиков*, *А. Ю. Щербук*

Под редакцией профессора *А. В. Самцова*

Рецензент:

К. И. Разнатовский — доктор мед. наук, профессор,
заведующий кафедрой дерматовенерологии СПбМАПО,
главный дерматовенеролог Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга

**Нейросифилис. Современные представления о диагностике
и лечении** : руководство для врачей / *А. В. Самцов*, *И. Н. Теличко*,
А. М. Иванов [и др.] / под ред. *А. В. Самцова*. — СПб.: СпецЛит,
2006. — 128 с. : ил.
ISBN 5-299-00321-8

В руководстве обобщены современные литературные сведения, данные собственных клинических и инструментально-лабораторных исследований авторов о патогенезе, течении, диагностике и лечении нейросифилиса.

Детально освещены современные методы серологической диагностики раннего нейросифилиса.

Издание предназначено для дерматовенерологов, неврологов, врачей-лаборантов.

УДК 616.5 616.8 616.9

ISBN 5-299-00321-8

© *А. В. Самцов*, *И. Н. Теличко*, 2006
© ООО «Издательство „СпецЛит“», 2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

Условные сокращения	4
Введение	6
Глава 1. История учения о нейросифилисе	9
Глава 2. Патогенез нейросифилиса	12
Глава 3. Классификация. Особенности клинического течения нейросифилиса	14
Глава 4. Методы исследования поражений нервной системы в различные периоды сифилиса	22
4.1. Цитологические и биохимические исследования	22
4.2. Микробиологическая диагностика	28
4.2.1. Обнаружение возбудителя в центральной нервной системе	28
4.2.2. Серологическая диагностика	29
4.3. Показатели интратекального гуморального иммунного ответа при сифилисе	53
4.4. Инструментальные методы исследования	59
4.4.1. Анатомо-физиологические особенности сосудистой системы головного мозга	59
4.4.2. Ультразвуковая доплерография	61
4.4.3. Взаимосвязь изменений цереброспинальной жидкости и нарушений церебральной гемодинамики при ранних формах сифилиса	69
4.4.4. Оценка вегетативных нарушений периферической нервной системы. Современные представления о взаимодействии нервной и иммунной систем, их возможная роль в течении сифилитической инфекции	72
4.4.5. Вегетативные нарушения и иммунитет	81
4.5. Нейровизуализационные методы исследования	86
Магнитно-резонансная томография в диагностике сифилитического поражения центральной нервной системы	86
Глава 5. Лечение нейросифилиса	94
Литература	102

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АДД	— диастолическое артериальное давление
АДФ	— аденозинфосфат
АлАТ	— аланинаминотрансфераза
АсАТ	— аспартатаминотрансфераза
АТФ	— аденозинтрифосфат
ВИ	— вегетативный индекс
ВИЧ	— вирус иммунодефицита человека
ВКВП	— вызванные кожные вегетативные потенциалы
ГТП	— γ -глутамилтрансептидаза
ГЭБ	— гематоэнцефалический барьер
ИЛ	— интерлейкины
ИН	— индекс напряжения (миокарда)
ИФА	— иммуноферментный анализ
КСР	— комплекс серологических реакций
КТ	— компьютерная томография
КФК	— креатинфосфокиназа
ЛДГ	— лактатдегидрогеназа
ЛП	— латентный период
ЛСК	— линейная скорость кровотока
МПК	— минимальная подавляющая концентрация
МР	— микрореакция преципитации
МРА	— магнитно-резонансная ангиография
МРТ	— магнитно-резонансная томография
ПЦР	— полимеразная цепная реакция
РИТ	— реакция иммобилизации бледных трепонем
РИФ	— реакция иммунофлюоресценции
РПГА	— реакция пассивной гемагглютинации
РС	— рассеянный склероз
РСК	— реакция связывания комплемента
САРС	— спектральный анализ ритма сердца
СЛЦ	— свободные легкие цепи (иммуноглобулинов)
СМА	— средние мозговые артерии
ФНО	— фактор некроза опухоли
ФСБ	— фосфатно-солевой буфер
ФСРТ	— фосфатно-солевой раствор с добавлением 0,1 % твин-20
ЦВР	— цереброваскулярная реактивность
ЦНС	— центральная нервная система

ЦСЖ	—	цереброспинальная жидкость
ЧСС	—	частота сердечных сокращений
ЩФ	—	щелочная фосфатаза
ЭЭГ	—	электроэнцефалограмма
Ig	—	иммуноглобулины
MIP	—	Maximum Intensity Projection
RI	—	индекс циркуляторного сопротивления Пурсело
RPR	—	Rapid Plasma Reagin (test)
S/D	—	систолюдиастолический коэффициент Стюарта
ТРНА	—	Treponema pallidum haemagglutination assay
TRUST	—	Toluidin Red Unheated Serum Test
USR	—	Unheated Plasma Reagin (test)
VDRL	—	Veneral Disease Research Laboratory (test)

ВВЕДЕНИЕ

По оценкам ВОЗ в 1999 г. в мире зарегистрировано 12 млн больных сифилисом, а в 2002 г. среди всех причин смертности в мире доля сифилиса составила 0,3 %. В течение долгого периода заболеваемость сифилисом в развитых странах находилась под контролем, однако в последние годы наблюдается ее рост. Например, в США заболеваемость в течение 40 лет была очень низкой, а с 2000 г. количество новых случаев прогрессивно увеличивается. Такая же ситуация наблюдается в Канаде и Европе. Большинство случаев сифилиса зарегистрировано у мужчин, практикующих секс с мужчинами, из них 75 % уже инфицированы ВИЧ. Взаимосвязь ВИЧ и сифилиса вызывает особенный интерес, так как описания клинических случаев позволяют предположить, что у ВИЧ-инфицированных пациентов, даже после полноценного лечения, нередко развивается нейросифилис.

Темпы роста заболеваемости сифилисом в первые годы эпидемии в Санкт-Петербурге значительно превышали показатели в среднем по России. Однако с 1996 г. ситуация резко изменилась: в Санкт-Петербурге раньше, чем в целом по России, наметилось стойкое снижение заболеваемости и показатель стабильно установился ниже среднероссийского (по данным 2003 г.).

Ретроспективный и сравнительный анализ заболеваемости более чем за 3 последних десятилетия свидетельствует о том, что в крупном столичном городе регистрируемый уровень заболеваемости не отражает истинную картину из-за теневого медицинского бизнеса, который начал особенно активно развиваться после 1994–1995 гг. Убедительно иллюстрируют это следующие цифры: в 1990 г. количество зарегистрированных случаев сифилиса по Санкт-Петербургу составило 8 % от общероссийского показателя, в 1995 г. — 5 %, в 1998 г. — 3,5 %, в 2002 г. — около 2 % (Смирнова Т. С., 2004).

По данным К. И. Разнатовского и Т. С. Смирновой (2005), в Санкт-Петербурге, несмотря на статистическое снижение уровня заболеваемости сифилисом — с 109,3 в 2001 г. до 49,2 в 2004 г.,

течение этой инфекции в настоящее время имеет угрожающий характер, что определяет неблагоприятный прогноз на ближайшие годы. Увеличивается количество скрытых форм (43,2 %), поздних форм (2,6 %), случаев нейросифилиса (5,5 %), серорезистентных форм (6 %), число беременных, больных сифилисом (5,5 %), детей с сифилисом (18 случаев), в том числе с врожденным (13 случаев). В 4 раза увеличилось количество случаев нейросифилиса, продолжает регистрироваться третичный сифилис.

В России отмечена стойкая тенденция к снижению заболеваемости сифилисом, которая за 7 лет снизилась в 4 раза и составила 79,2 случаев на 100 000 населения. За этот же период количество случаев врожденного сифилиса уменьшилось более чем в 2 раза. Относительно благоприятный прогноз подтверждается динамикой снижения количества ранних форм сифилиса. В то же время заболеваемость сифилисом в России все еще превышает показатели многих стран. Несмотря на то что темпы снижения заболеваемости в последние 5 лет стабильны, они все еще крайне медленны.

На распространенность сифилиса влияют множество факторов:

- качество работы дерматовенерологов, направленной на выявление и лечение больных;

- совокупность условий жизни и поведения каждого человека в отдельности и коллектива в целом;
- плотность населения, урбанизация, миграционные процессы;
- материальное благосостояние, уклад жизни, воспитание, уровень общей культуры;
- состояние здравоохранения, в частности дерматовенерологической службы;
- внедрение специфических методов диагностики заболеваний;
- изменчивость штаммов возбудителя инфекции;
- наличие атипичных, бессимптомных клинических форм заболевания;
- свободная продажа антибиотиков и возможность самолечения;
- использование средств индивидуальной профилактики.

Массовое бесконтрольное применение антибактериальных препаратов приводит к изменению клинической картины и более частому появлению редких форм заболевания, сложных для обычной диагностики. Увеличение числа частнопрактикующих врачей, проводящих неполноценное лечение, не применяющих клинико-серологический контроль, способствует возрастанию доли больных с поздними формами сифилиса. Существенное влияние на изменение клинического течения сифилиса оказывает возможность сопут-

ствующего инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Кроме того, в связи со сложным экономическим положением в стране опасная ситуация сложилась в службе крови: оплата кроводачи стимулирует вовлечение в контингент доноров людей с повышенным риском инфекций, передающихся половым путем.

В последние годы на фоне снижения заболеваемости сифилисом наблюдается увеличение количества случаев поражения нервной системы при этой инфекции. Результаты сравнительного анализа позволяют говорить о прогрессивном увеличении числа больных с нейросифилисом с 19 в 1992 г. до 220 в 2002 г. (по официальным данным).

Растет интерес исследователей к проблеме нейросифилиса, что отражено в появлении ряда публикаций, посвященных изучению поражений нервной системы в ранних периодах сифилиса (Платонов С. И. [и др.], 1989; Борисенко К. К. [и др.], 1998; Потекаев Н. С. [и др.], 1998; Roberts M. C. [et al.], 1992; Russouw H. G. [et al.], 1995; Moskophidis M., Peters S., 1996).

Проблема ранней диагностики нейросифилиса всегда стояла остро, поскольку в большинстве случаев сифилитический процесс в центральной нервной системе (ЦНС) протекает асимптомно и не имеет четких специфичных клинических признаков (Wolters E. C. [et al.], 1988; van Kamp G. J., Wolters E. C., 1989). Одновременно ряд научных публикаций в этой области свидетельствуют об изменении течения сифилиса и патоморфозе клинических проявлений данной инфекции. Указывается на превалирование в клинической картине нейросифилиса ранних форм. С 1995 по 2002 г. диагностировались все новые случаи нейросифилиса с тяжелым и среднетяжелым течением. В структуре поздних форм сифилиса наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в отношении сифилиса нервной системы.

Перспективной является разработка новых высокоинформативных чувствительных и специфичных способов диагностики сифилиса в целом и нейросифилиса в частности.

Даже при наличии данных клинических и лабораторных исследований, подтверждающих сифилитическое поражение нервной системы, отсутствует единый подход к лечению этой патологии. Нейросифилис нередко приводит к значительной инвалидизации больных.

Все это доказывает высокую актуальность изучения данной проблемы.

Глава 1

ИСТОРИЯ УЧЕНИЯ О НЕЙРОСИФИЛИСЕ

Учение о нейросифилисе возникло в конце XV в., когда пандемия сифилиса опустошила Западную и Центральную Европу. Сифилис считали тогда черной смертью, чумой. По данным того времени, у выживших после сифилиса оставались заболевания внутренних органов — висцеральный сифилис и параличи.

Возможность поражения внутренних органов при сифилисе была описана уже Ульрихом фон Хуттенom и Парацельсом и в XVII столетии считалась общепризнанной. Ульрих фон Хуттен, например, в 1519 г. упоминал параличи у сифилитиков; происхождение этих параличей он приписывал применению с лечебными целями ртути. Первым же, кто высказал мнение о заболевании сифилисом вследствие заражения организма особым ядом, был известный врач, метафизик и алхимик XVI столетия Теофраст Бомбаст Парацельс. По его мнению, производящая причина заключалась в особой венерической миазме, которая, раз введенная в организм, проникает во все его ткани и органы и производит весь симптомокомплекс болезненных явлений.

По мнению знаменитого сифилидолога XVI столетия Йоханнеса Фернеля (Johannes Fernelius), причина заболевания сифилисом заключается в особенном яде, передаваемом от больного человека здоровому и связанном с известным количеством жидкости или другого вещества, при помощи которого этот яд и вносится в организм.

Первое патологоанатомическое наблюдение сифилитических поражений головного мозга принадлежит Баллониусу (1616), описавшему гуммозное новообразование в мамиллярных тельцах мозга. Баллониус определил этот процесс как скирроподобный (Маргулис М. С., 1949).

В дальнейшем этот взгляд был основательно забыт, и в XVIII столетии Хантер учил, что сифилис никогда не поражает внутренних органов, а является исключительно заболеванием кожи. Этот взгляд господствовал до середины XIX столетия.

Только в 1834 г. Лаллеман, основываясь на результатах собственных патологоанатомических исследований нервной системы

при сифилисе, определенно заявил, что сифилис вызывает поражение мозговых оболочек и вещества мозга.

После работы Лаллемана во второй половине XIX в. появился ряд работ и описаний казуистических случаев, посвященных сифилису нервной системы. Одна из первых работ принадлежала Грингеру, который в 1860 г. описал новую в то время форму сифилитического менингита. Тогда же Карл Вестфаль установил связь и зависимость между сифилисом и психическими заболеваниями.

На данных собственных исследований и работ других авторов Рикор основал новое учение, что сифилисом поражаются не только кожа, слизистые оболочки и кости, но и внутренние органы.

Значительную роль в развитии учения о нейросифилисе сыграли два открытия в области патологической анатомии сифилитической инфекции, связанные с именами Вирхова и Хейбнера. Вирхов описал морфологическую картину гуммы, Хейбнер — изменения сосудов при сифилисе — облитерирующий эндартериит и эндофлебит (Маргулис М. С., 1949).

Еще в самом конце XIX столетия вопрос об этиологии нейросифилиса, особенно его поздних форм, не был решен. Одни авторы, такие как Кожевников, Минор, Муратов, Эрб, Фурнье, Штрюмпель, признавали прямую причинную зависимость между сифилисом и поражениями нервной системы, которые наблюдаются при этом заболевании, особенно при позднем нейросифилисе — прогрессивном параличе и спинной сухотке. Другая группа исследователей во главе с Лейденом рассматривала прогрессивный паралич и спинную сухотку как формы, косвенно и непостоянно связанные с сифилисом; в некоторых же случаях, по мнению этих авторов, прогрессивный паралич и спинная сухотка могут развиваться и без предшествующего сифилиса.

Научное изучение сифилиса нервной системы началось в конце XIX столетия, когда А. Альцгеймер (A. Alzheimer) описал сифилитические поражения ЦНС — острый сифилитический менингомиелит и энцефалит. В начале XX в., как правило, изучались поздние формы нейросифилиса — прогрессивный паралич, спинная сухотка, цереброспинальный сифилис.

Фурнье во Франции и Эрб в Германии, устанавливавшие связь между наличием сифилиса, с одной стороны, и развитием прогрессивного паралича и табеса — с другой, встретили на первых порах очень резкую оппозицию своим новым идеям о нейролюэсе. В России Ковалевский и Даркшевич горячо защищали гипотезу о сифилитическом происхождении прогрессивного паралича и табеса. Окончательное торжество этой идеи относится только ко времени открытия Ф. Р. Шаудинном (F. R. Shaudinn) *Spirochaeta pallida*

(бледной спирохеты) и разработки А. Вассерманом реакции связывания комплемента. С тех пор учение о нейрролюэсе было детально разработано и выросло в стройную систему, и потому наряду со старым представлением о кожном сифилисе в сознание врачей уже прочно внедрилось представление о сифилисе нервной системы и о новейших методах его распознавания и лечения (Лурия Р. А., 1925).

Впервые бледная спирохета после ее открытия Ф. Р. Шаудинном найдена Ранке в 1906 г. в головном и спинном мозге при врожденном сифилисе плода. Вскоре бледная спирохета была обнаружена при менингоэнцефаломиелите (Маргулис М. С., 1949).

Понятие «нейросифилис» («нейрролюэс») фигурировало в работах Фурнье, однако термин стал приживаться лишь в первой половине XX в. До этого времени, несмотря на множество работ, посвященных подробным описаниям и систематизации клинических проявлений и патоморфологических признаков сифилитического поражения нервной системы, данное понятие активно не использовалось (Сифилис нервной системы..., 1889; Бехтерев В. М., 1902).

В 1925 г. Р. А. Лурия указывал на частую встречаемость сифилитических поражений внутренних органов и нервной системы и зачастую бессимптомный, скрытый характер течения заболевания.

Отечественными учеными уделялось много внимания изучению нейросифилиса (поздних форм) в 20–30-е годы XX в., когда на фоне высокой общей заболеваемости сифилисом (около 500 случаев на 100 000 населения) на нейросифилис приходилось около 10 % всей неврологической патологии. Ранний нейросифилис подробно изучали в 1940–1960-е годы Н. С. Ведров, Г. В. Робустов, П. И. Иерусалимский. В частности, Г. В. Робустов предложил одну из классификаций раннего нейросифилиса. В эти годы также разрабатывались методы профилактики нейросифилиса, включающие раннее, с использованием ликвородиагностики, выявление поражений нервной системы и назначение больших доз антибактериальных препаратов.

Во второй половине XX в. наблюдались существенные изменения в клинической картине и течении сифилиса нервной системы и других органов. В структуре поражений нервной системы произошло перераспределение клинических форм: мезенхимные формы нейросифилиса (сосудистый нейросифилис) стали значительно преобладать над паренхиматозными (табес, прогрессивный паралич) (Милич М. В., 1972).

В последнее время отмечается тенденция к увеличению количества случаев раннего нейросифилиса (Flood J. M. [et al.], 1998), среди которых преобладают менинговаскулярные формы (Титова А. В., Алимова Г. И., 1983; Lowenstein D. [et al.], 1987).

Глава 2

ПАТОГЕНЕЗ НЕЙРОСИФИЛИСА

О поражении нервной системы в самой ранней стадии развития сифилитической инфекции свидетельствуют данные F. Ebersson, M. E. Engmann (1921), которые установили, что бледные трепонемы уже в первые дни после заражения обнаруживаются в оболочках нервов и периневральных лимфатических пространствах. Они высказали предположение о том, что возбудитель может продвигаться вдоль нервного волокна и таким путем проникать в ЦНС. В 1924 г. A. M. Chesney и J. E. Kemp обнаружили бледную трепонему в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) при ранних стадиях сифилиса. В 1994 г. K. Y. Chung и соавт. с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) обнаружили бледную трепонему в ЦСЖ у всех обследованных пациентов с разными стадиями сифилиса. Ряд авторов (Робустов Г. В., Студинин А. А., 1964; Робустов Г. В., 1965; Фридман А. П., 1971) считают, что инвазия трепонем в ЦНС происходит в 100 % случаев заболевания сифилисом, а мозговые оболочки и сосуды представляют собой благоприятную почву для их размножения.

Формированию нейросифилиса у больных способствуют психические и физические травмы, нейроциркуляторные расстройства, интоксикации, хронический алкоголизм, перенесенные ранее воспалительные процессы ЦНС несифилитической этиологии, ВИЧ-инфекция. Частота выявления алкоголизма у пациентов с нейросифилисом по данным разных авторов колеблется в пределах от 10,8 % (Ломыскин А. И. [и др.], 1979) до 15,6 % (Разнатовский И. М. [и др.], 1996).

Отмечается также связь между нейросифилисом и серорезистентностью: скрытый специфический менингит выявляется у 20 % пациентов с истинной серорезистентностью.

Проникая в нервную систему, бледная трепонема находит защиту от пенициллина и условия для образования L- и цист-форм. Между организмом и бледной трепонемой устанавливается состояние равновесия, что способствует персистенции возбудителя в тканях, являющихся иммунологически «привилегированными» зонами вследствие наличия гематоэнцефалического барьера. Этому могут способствовать и незавершенный фагоцитоз, тенденция к снижению содержания циркулирующих иммунных комплексов и интерлейкина-2 (ИЛ-2), отмечаемая при скрытом течении сифилиса и при нейросифилисе.

Внутриклеточное паразитирование возбудителя связывают, в частности, со снижением показателей супрессорно-киллерного звена иммунитета при вторичном сифилисе.

В ряде случаев (беременность, алкоголизм) при реверсии бледных трепонем из цист-форм развиваются спиралевидные варианты с нагноением, по сравнению с исходной, вирулентностью.

Развитие защитной реакции со стороны нервной системы приводит к воспалению, в первую очередь в оболочках мозга.

Внутриоболочечная продукция иммуноглобулинов является причиной поражения нервной ткани за счет аутоиммунных реакций. Непосредственное инфекционно-аллергическое поражение комплекса интима-медиа церебральных артерий сопровождается набуханием и сужением просвета. Кроме того, появляются сдвиги вегетативной регуляции сосудистой стенки, связанные с поражением ганглиозных клеток и гипоталамической области. Все это приводит к ишемии, утрате корковых нейронов с пролиферацией нейроглии и развитием паралитической деменции.

Со стороны нервной системы уже в инкубационном периоде обнаруживаются макро- и микроскопические изменения (Горбовицкий С. Е., 1944; Малыкин Р. Я., 1953). Специфический характер поражения нервной системы подтверждается результатами патологоанатомических исследований у случайно умерших больных. На вскрытии обнаруживалась характерная для сифилиса лимфоидно-плазматическая инфильтрация оболочек головного мозга, которая наблюдалась даже в тех случаях, когда ЦСЖ была интактной (Робустов Г. В., 1950, 1965; Graman P. S. [et al.], 1987).

Патологические изменения на ранних стадиях сифилиса являются не только в ЦНС, но и в миелиновых и безмиелиновых волокнах. При исследовании ультратонких срезов нервных волокон обнаружены патологические изменения эпи-, пери- и эндоневрия. Кроме того, установлено, что бледные трепонемы могут проникать в большом количестве в нервные волокна еще на стадии серонегативного сифилиса (Овчинников Н. М. [и др.], 1980).

В патогенезе неврологических расстройств в разные периоды сифилиса большое значение имеют повышение внутриоболочечной продукции иммуноглобулинов и изменение активности ферментов ЦСЖ. Эти изменения лежат в основе формирования как субклинических форм в виде менингovasкулярных реакций и синдрома нейроциркуляторной дистонии, так и манифестных форм в более тяжелых случаях. Дисфункция вегетативной нервной системы возникает рано и существенно влияет на течение всего периода заболевания, определяя степень трофических расстройств и выраженность гуморальных защитных реакций. Глубина изменения мозговой гемо-

динамики, биоэлектрической активности головного мозга коррелирует с выраженностью структурных изменений ЦНС при сифилисе.

Однако возникает вопрос: почему манифестные формы нейросифилиса на ранних стадиях заболевания встречаются лишь в относительно небольшом проценте случаев? Это можно объяснить наличием большого количества скрытых форм, которое продолжает увеличиваться (Милич М. В., 1980; Главинская Т. А., 1996; Скрипкин Ю. К., 1998; Smikle M. [et al.], 1988). Это обусловлено, во-первых, высокими защитными свойствами организма, во-вторых, применением препаратов пенициллинового ряда, которые не создают необходимых бактерицидных концентраций в ЦНС при назначении их в обычных дозах (Goldmeier D., Nau P., 1993; Crowe G. [et al.], 1997), а в-третьих, эволюцией патогенных свойств бледной трепонемы (Милич М. В., 1987).

Таким образом, уже на ранних стадиях сифилитической инфекции, начиная с инкубационного периода, происходит инвазия бледной трепонемы в центральную и периферическую нервную систему.

Глава 3

КЛАССИФИКАЦИЯ. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ НЕЙРОСИФИЛИСА

Различают ранний (мезенхимный) нейросифилис (до 5 лет от момента заражения) и поздний (паренхиматозный) нейросифилис (более 5 лет от момента заражения). Начальный период ранних форм длится 2 года, общая продолжительность раннего нейросифилиса составляет 3—5 лет. Патоморфологическим субстратом воспалительного процесса являются лимфоидно-плазматические реакции в структурах мезодермального происхождения, в мягких мозговых оболочках и сосудах головного и спинного мозга.

Признаки позднего нейросифилиса проявляются в течение 10—15 лет после заражения. Морфологическим субстратом при поздних формах нейросифилиса наиболее часто является специфическая гранулема с вторичным аутоиммунным поражением сосудов, оболочек и вещества мозга. Такое подразделение нейросифилиса условно: ранний нейросифилис может развиваться спустя многие годы после заболевания сифилисом, наряду с этим, особенно при

инфицировании ВИЧ, известны случаи раннего проявления табопаралича и спинной сухотки.

М. С. Маргулис (1949), Boudin (1964) рассматривают ранний и поздний сифилис как единый процесс.

Г. В. Робустов (1950) выделяет следующие формы раннего нейросифилиса:

- 1) сифилитический асимптомный менингит;
- 2) переходные формы (начальная и стертая симптоматика);
- 3) острый манифестный сифилитический менингит, в том числе генерализованный менингит, менингоневрит, острая гидроцефалия, менингovasкулярная форма, смешанная форма, нейрорецидив;
- 4) сифилис задних отделов глаза и внутреннего уха;
- 5) ранний диффузный менингovasкулярный сифилис — менингоэнцефаломиелопатия;
- 6) васкулярный сифилис мозга — инсульты, эпилепсия, гемиплегия, афазия.

В настоящее время в раннем нейросифилисе выделяют (Яхно Н. Н. [и др.], 1995; Berkow R., 1982; Singh A. [et al.], 1999):

- 1) асимптомный нейросифилис;
- 2) сифилитический менингит (острый или подострый, в том числе с вовлечением черепных нервов);
- 3) менингovasкулярный нейросифилис, в том числе миелопатии.

О. К. Шапошников (1991) и И. И. Мавров (1994) приводят расширенную клиническую классификацию:

- 1) скрытый (латентный) сифилитический менингит;
- 2) базальный менингит (менингоневритическая форма сифилитического менингита);
- 3) острый генерализованный (манифестный) сифилитический менингит;
- 4) сифилитическая гидроцефалия;
- 5) сифилитический менингомиелит;
- 6) ранний менингovasкулярный сифилис.

Приводим современную классификацию клинических форм нейросифилиса (Одинак О. М., Попов А. К., 2000).

1. Ранние (мезодермальные) формы:
 - Ранний сифилитический менингит.
 - Латентный (асимптомный) менингит — ликворосифилис.
 - Острый лихорадочный сифилитический менингит (менингоэнцефалит, менингомиелит).
 - Гипертрофический пахименингит.
 - Сосудистая форма с поражением головного и спинного мозга.
 - Гуммы головного и спинного мозга.

Самцов Алексей Викторович, **Труфанов** Геннадий Евгеньевич,
Тотолян Наталья Агафоновна, **Иванов** Андрей Михайлович,
Никоненко Марина Николаевна, **Одинак** Олег Мирославович,
Теличко Игорь Николаевич, **Готовчиков** Андрей Александрович,
Щербук Андрей Юрьевич

Учебное издание

НЕЙРОСИФИЛИС.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ

Руководство для врачей

Под редакцией А. В. Самцова

Ответственный редактор А. А. Редкокаша
Редактор Т. В. Руксина
Техническое редактирование
и компьютерная верстка И. Ю. Илюхиной
Корректор Т. В. Тетерюкова

Подписано в печать 30.06.2006. Формат 60 × 88¹/₁₆. Усл. печ. л. 8.
Тираж 1000 экз. Заказ №

ООО «Издательство „СпецЛит“».
190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29,
тел./факс: (812) 251-66-54, 251-16-94,
<http://www.speclit.spb.ru>.

Отпечатано с диапозитивов ООО «Издательство „СпецЛит“»
в ГП ПО «Псковская областная типография»
180007, г. Псков, Рижский пр., 17.

ISBN 5-299-00321-8



9 785299 003215